



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG
DENGAN
RSUD dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR : 178/SP/PKU.S/X/2025
NOMOR : 000-A.F.2/9A/PRS/X/2025
TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (13-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. H.HASAN BAYUNI : Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng berkedudukan di Sruweng, beralamat di Jalan Raya Sruweng Nomor 5 Sruweng, Kebumen, berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen tentang Pengangkatan Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Sruweng Nomor 68/KEP/III.0/D/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSU PKU Muhammadiyah Sruweng yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. dr. H. ARIF KOMEDI, M.Sc : Direktur RSUD Dr. Soedirman Kebumen, berkedudukan di Kebumen, beralamat di Jalan Kebumen Raya Nomor 232 Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Kode Pos 54317, diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 821.2.1/04/KEP/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumendalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD Dr. Soedirman Kebumen selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Paraf	
Pihak I	Pihak II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan untuk masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen adalah institusi Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
2. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Sruweng adalah rumah sakit swasta milik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sruweng yang beralamat di Jalan Raya Sruweng Nomor 5 Sruweng;
3. Direktur Utama Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Sruweng adalah pemegang jabatan struktural tertinggi dan penanggungjawab dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Sruweng;
4. Direktur RSDS Kebumen adalah pemegang jabatan struktural tertinggi dan penanggungjawab dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen;
5. Pihak Pengirim Rujukan adalah Pihak yang merujuk pelayanan kesehatan Pasien kepada Pihak Penerima Rujukan;
6. Pihak Penerima Rujukan adalah Pihak yang menerima rujukan Pasien dari Pihak Pengirim Rujukan;
7. Pasien adalah pasien yang dirujuk Pihak Pengirim Rujukan kepada Pihak Penerima rujukan untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan medis sesuai surat rujukan dan/atau surat pengantar;
8. Surat Rujukan adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik secara vertical maupun horizontal..
9. Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal.

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam pelaksanaan kerja sama pelayanan rujukan kesehatan yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya di sebut “Perjanjian’ dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
0.	

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelayanan rujukan kesehatan terhadap pasien PIHAK KESATU untuk mendapatkan pelayanan rawat inap dan/atau pemeriksaan penunjang yang belum dimiliki oleh PIHAK KESATU.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Intensif, Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap, Rujukan Tindakan Spesialis, dan Pelayanan Penunjang yang tidak dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU.

BAB III
PROSEDUR RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU akan merujuk Pasien apabila:
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisistik atau sub spesialisistik;
 - b. Tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, penunjang dan fasilitas kesehatan dan/atau ketenagaan.
- (2) PIHAK KEDUA akan merujuk kembali Pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KESATU apabila :
 - a. Permasalahan kesehatan Pasien dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan;
 - b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KESATU akan lebih baik dalam menangani Pasien tersebut;
 - c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
 - d. PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (3) PIHAK KESATU harus mendapatkan persetujuan dari Pasien dan/atau keluarga Pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU sebelum merujuk terlebih dulu melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. melakukan komunikasi awal dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam keadaan pasien gawat darurat;
 - c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan yang paling sedikit memuat :
 1. identitas pasien;
 2. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 3. terapi dan/atau tindakan yang diberikan;
 4. tujuan rujukan;
 5. nama dan tanda tangan tenaga yang memberikan pelayanan;
 6. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan; dan
 7. status pembiayaan pasien
 - d. menginformasikan pada pasien rujukan agar membawa dokumen kependudukan dan dokumen kesehatan serta dokumen lain yang diperlukan atau dilengkapi kemudian dalam jangka waktu 2x24 jam.
- (2) Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh tenaga medis, dikecualikan pada keadaan gawat darurat maka surat pengantar rujukan dapat dilakukan oleh bidan/perawat.
- (3) Komunikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PIHAK KESATU menghubungi PIHAK KEDUA untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan sarana prasarana, kompetensi, dan tenaga kesehatan.
- (4) Pelayanan yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU akan dilayani selama 24 jam.
- (5) Pendaftaran pasien dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan berdasar pada surat rujukan yang dibawa oleh PIHAK KESATU.
- (6) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PARA PIHAK menjamin telah memiliki otorisasi dari Pasien dan bertanggungjawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut.

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU pada saat mengirim rujukan ke PIHAK KEDUA, pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulance dan didampingi oleh tenaga yang berkompeten.
- (2) Dalam hal tidak tersedia ambulance pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, maka rujukan dapat dilakukan dengan alat transportasi lain yang layak.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (3) Petugas medis/paramedis yang mendampingi rujukan pasien harus menunjukkan identitas yang jelas bahwa yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan.
- (4) Penempatan pasien PIHAK KESATU yang memerlukan pelayanan rujukan kesehatan disesuaikan dengan kelas perawatan yang diminta oleh pihak keluarga yang bertanggungjawab.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN Pasal 6

- (1) Biaya pelayanan kesehatan pasien berupa pemeriksaan penunjang yang dirujuk oleh PIHAK KESATU menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU, sedangkan untuk pelayanan kesehatan rawat inap menjadi tanggungjawab pasien.
- (2) Tarif pelayanan ditentukan berdasarkan daftar tarif yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran biaya pelayanan akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU setiap satu bulan sekali pada bulan berikutnya setelah PIHAK KEDUA mengirimkan invoice untuk dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU.
- (4) Apabila terdapat perubahan tarif pelayanan, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perubahan tarif diberlakukan.
- (5) Pembayaran dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara pemindahbukuan melalui rekening PIHAK KEDUA:
Atas Nama Rekening : BLUD RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
Nomor Rekening : 1008002874
Bank : Bank Jateng Cabang Kebumen
- (6) Dalam hal adanya keterlambatan pembayaran selama dua bulan, maka PIHAK KESATU dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari pembayaran tersebut.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan lanjutan bagi pasien rujukan PIHAK KESATU secara lebih lengkap, bermutu dan profesional dari PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh informasi, penjelasan dan data yang diperlukan sebagai dasar untuk perbaikan mutu pelayanan kesehatan selama proses rujukan berlangsung; dan
 - c. menerima umpan balik hasil rujukan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. mendapatkan informasi dan data mengenai keadaan pasien yang dirujuk PIHAK KESATU; dan

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- b. menerima pembayaran atas pelayanan yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. melakukan prosedur rujukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. menaati tata tertib dan ketentuan pelayanan yang berlaku pada PIHAK KEDUA; dan
 - c. melakukan pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. menerima rujukan dari PIHAK KESATU sesuai dengan Standar Prosedur Operasional;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan secara lengkap, bermutu dan profesional sesuai Standar Prosedur Operasional ;
 - c. menyediakan Layanan Informasi melalui telepon untuk pelayanan kegawatdaruratan dengan operator penerima telepon yang mengetahui:
 - 1. terminologi di Rumah Sakit;
 - 2. jenis dan tarif pelayanan;
 - 3. tenaga jaga/*on duty* (dokter, perawat/bidan dan tenaga penunjang); dan
 - 4. Sarana prasarana yang tersedia.
 - d. memberikan informasi dan edukasi terkait tarif dan pembiayaan;
 - e. memberikan umpan balik terhadap kasus yang dirujuk secara tertulis dan dikirim kepada PIHAK KESATU; dan
 - f. mengirimkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi apabila diperlukan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2025 sampai dengan 30 Oktober 2028 dan akan dievaluasi setiap semester berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu PIHAK hendak memperpanjang Perjanjian ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian ini harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK lain dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VII
KERAHASIAAN MEDIS
Pasal 9

PARA PIHAK selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah berakhir jangka waktunya dan PARA PIHAK tidak berkeinginan memperpanjang jangka waktu; dan/atau
 - b. adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) Pengakhiran Perjanjian tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing PIHAK yang belum terlaksana sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian.
- (3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, masing-masing PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya putusan pengadilan dalam pengakhiran suatu perjanjian.

BAB IX
FORCE MAJEURE
Pasal 11

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan Force Majeure adalah hal-hal yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan di luar kemampuan PARA PIHAK, terkecuali kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis, paling lambat 1 (satu) bulan kalender saat terjadi peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut.
- (3) Masing-masing PIHAK tidak akan menuntut PIHAK lain atas tertundanya pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh Force Majeure.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>I.</i>	<i>Mg</i>

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kebumen.

BAB XI
ALAMAT KORESPONDENSI
Pasal 13

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan, apabila terdapat tanda penerimaan yang sah dari PIHAK yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : RSUD PKU Muhammadiyah Sruweng
Jalan Raya Sruweng No 5 Kebumen
Email: rspkumuhammadiyahsruweng@yahoo.co.id
Telp. (0287) 382597
Tri Dina Lestari, S.Kep.Ns (Manajer Bindatra)
No Hp : 081327667333

PIHAK KEDUA : RSUD Dr. Soedirman Kebumen
Jalan Kebumen Raya Nomor 232 Muktisari,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah 54317
Email : rsud@kebumenkab.go.id
Telp. (0287) 381101

BAB XII
ADDENDUM
Pasal 14

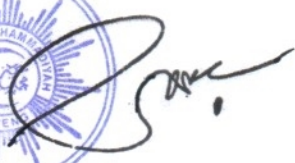
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>P.</i>	<i>MA</i>

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu buah untuk PIHAK KESATU dan satu buah lagi untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
DIREKTUR UTAMA RSU
PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG



dr. H. HASAN BAYUNI

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD dr. SOEDIRMAN
KEBUMEN



dr. H. ARIF KOMEDI, M.Sc.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	